

RECURSO CÍVEL Nº 5026364-21.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: MANOEL MOREIRA (AUTOR)

ADVOGADO(A): MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5026364-21.2024.4.02.5001

500003661838 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5026364-21.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: MANOEL MOREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

2. Em suas razões, alega cerceamento de defesa (quesitos não respondidos pela perícia judicial) e, no mérito, afirma que sofreu infarto agudo do miocárdio e que, em razão disso, encontra-se incapacitado para o trabalho. Argumenta que os laudos médicos particulares confirmam essa alegação. Ao final, pede a reforma ou a anulação da sentença.

3. Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

4. A sentença julgou o pedido nos seguintes termos:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio por incapacidade temporária com sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, desde 11/6/2024.

O requerimento administrativo de auxílio por incapacidade temporária NB 31/650.223.562-3, formulado em 11/6/2024, foi indeferido porque a perícia médica administrativa não constatou incapacidade para o trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO6).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em cardiologia, reportou infarto agudo do miocárdio com supra em 22/10/2023, submetido a angioplastia coronariana primária com sucesso e cateterismo com lesões residuais moderadas, sem indicação de angioplastia. Diagnosticou hipertensão essencial (primária), efeito tóxico do tabaco e da nicotina, infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio e doença isquêmica crônica do coração. Afirmou que o autor possui aptidão para exercer a atividade habitual de pintor. Concluiu que não há incapacidade para o trabalho (evento 22).

Conclusão: sem incapacidade atual

- *Justificativa:* Autor com diagnóstico de doença arterial coronariana obstrutiva e infarto do miocárdio submetido a tratamento efetivo com angioplastia coronariana, atualmente compensado, em uso regular das medicações, sem agravamentos ou interações recentes, não apresenta outra lesão coronarianas grave ao cateterismo, sem evidência de isquemia ou disfunção ventricular residual. Apresenta, portanto, capacidade física para o trabalho.

- *Houve incapacidade pretérita em período(s) além daquele(s) em que o(a) examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário?* NÃO

- *Caso não haja incapacidade atual, o(a) examinado(a) apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza?* NÃO

O autor impugnou o laudo pericial (evento 32, PET1). Alegou que:

CUMPRE DESTACAR QUE OS QUESITOS APRESENTADOS PELA REQUERENTE NA EXORDIAL NÃO FORAM RESPONDIDOS NO LAUDO PERICIAL COMO PRECEITUA O ART. 473, IV DO CPC, PORTANTO, REQUER QUE SEJAM OS MESMOS RESPONDIDOS, SOB PENA DE NULIDADE.

Todas as questões relevantes para o julgamento da lide já foram esclarecidas com as respostas ao rol de quesitos existentes no Laudo Pericial Eletrônico disponível no sistema e-Proc, cuja utilização nos processos previdenciários tornou-se obrigatória, conforme Ofício TRF2-OCI-2023/00121, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região. Por isso, é dispensável submeter ao perito o rol de quesitos que o autor apresentou junto com a petição inicial.

O autor alegou que:

Primeiramente precisamos salientar que o Requerente realizava atividades laborais como **PINTOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL**. Logo, dentre suas atividades estão preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta, dentre várias outras atividades, ou seja, o seu trabalho exige total capacidade.

O perito avaliou que o autor apresentou bom estado geral, corado e hidratado, acianótico, lícido e orientado em tempo e espaço, murmúrio vesicular rude e reduzido em ambos hemitóraces, sem ruídos adventícios, ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas, sem sopros, boa perfusão capilar periférica, sem sinais clínicos de congestão, extremidades quentes e bem perfundidas, pulsos amplos e simétricos, sem edema periférico. Pressão arterial 120x80 mmhg e frequência cardíaca de 94 batimentos por minuto (evento 22). Não há motivos para supor que o autor não possa exercer plenamente a atividade de pintor de construção civil. Para ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença tenha causado alterações que impeçam o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação.

O autor alegou que:

Consoante a isso, o Requerente, nascido em 29/06/1965, com **59 ANOS DE IDADE**, trabalhou como pintor de construção civil por mais de 30 anos. Porém, em outubro de 2023, sofreu um infarto agudo do miocárdio, sendo submetido a angioplastia coronariana primária, desde então, apresenta quadro de doença

arterial coronariana obstrutiva, hipertensão arterial e histórico de tabagismo, que foi interrompido após o infarto.

A idade avançada e o baixo grau de instrução são fatores que não autorizam presumir a impossibilidade de recuperação da capacidade para o trabalho. No máximo, eles poderiam inviabilizar a reabilitação profissional, caso comprovada incapacidade definitiva para a atividade habitual.

Só é indispensável a análise das condições pessoais do segurado quando houver sido reconhecida incapacidade parcial para o trabalho. De acordo com a Súmula nº 77 da Turma Nacional de Uniformização, “O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual”.

O autor alegou que:

O laudo pericial afirma que o Requerente se encontra compensado, sem evidência de isquemia ou disfunção ventricular residual, mas os documentos médicos anexados aos autos demonstram que o Requerente ainda apresenta sintomas de dor torácica e limitação física significativa, incompatíveis com a conclusão de plena capacidade laboral.

O autor recebeu o auxílio por incapacidade temporária NB 31/646.498.469-5 no período de 6/11/2023a 17/1/2024 (evento 2, INFBEN3). Com a petição inicial, o autor exibiu laudo médico datado de 25/10/2023 (evento 1, LAUDO4). O autor não exibiu laudo médico posterior a cessação do benefício para subsidiar a alegação de persistência da incapacidade para o trabalho.

Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de benefício por incapacidade (seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), qual seja, a prova da incapacidade para o trabalho.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

5. Segundo a sentença, a perícia médica judicial atestou que, embora o autor sofresse de doenças cardíacas, ele não estava incapacitado para a sua atividade de pintor, porque estava “atualmente compensado, em uso regular das medicações, sem agravamentos ou internações recentes, não apresenta outra lesão coronarianas grave ao cateterismo, sem evidência de isquemia ou disfunção ventricular residual” (ev. 22, LAUDPERI1). Sobre a alegação de cerceamento de defesa, depreende-se do laudo da perícia médica judicial que, após a realização de exame físico no autor e da avaliação dos documentos médicos juntados aos autos, o “expert” apresentou respostas satisfatórias aos quesitos formulados. Ademais, as respostas aos quesitos formulados ou foram diretamente fornecidas pela perícia médica judicial ou podem ser obtidas pela lógica do raciocínio desenvolvido pelo perito do juízo.

6. Esclareça-se que, nos termos do enunciado n. 08 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

7. Para infirmar o laudo da perícia judicial, o autor precisaria produzir prova robusta no sentido de que a sua incapacidade existia no grau e na duração que alega. Entretanto, não foi esse o caso, visto que o laudo médico particular de ev. 1, LAUDO4, fl. 01, apesar de solicitar o seu afastamento por 30 dias em 25.10.2023, não é contemporâneo ao requerimento administrativo (11.06.2024 - ev. 1, INDEFERIMENTO6). Desse modo, não é capaz de infirmar as conclusões da perícia médica judicial, acolhidas pela sentença. Os laudos médicos particulares apresentados após a realização da perícia médica judicial não podem ser considerados como prova, pois violariam o princípio do contraditório e da ampla defesa (Enunciado n. 84 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro).

8. Assim, considerando que o recorrente não apresentou elementos capazes de justificar a reforma ou anulação da sentença, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

9. Condene o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

10. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do autor.